ASTHME ET BPCO : LES TRAITEMENTS INHALÉS

Corticoïdes, bêta-2 mimétiques, anticholinergiques : qui fait quoi, pour qui ?

Fiche conseils DOTR - France - version du 05/11/2026 - spécialités : BDPM et EMA au 05/11/2026

POINT CLÉ

Asthme : le **corticoïde inhalé (CSI)** est le socle du traitement de fond ; un bêta-2 de longue durée (BDLA) ne se prescrit **jamais sans CSI**. **BPCO** : le socle, ce sont les **bronchodilatateurs de longue durée** (LAMA et/ou BDLA) ; le CSI ne s'ajoute qu'en cas d'**exacerbations**, guidé par les **éosinophiles**, et jamais seul.

Famille	Molécules (DCI)	Asthme	BPCO	À retenir
BDCA bêta-2 de courte durée	salbutamol, terbutaline	**Secours (crise, effort)**	**Secours**	Asthme : jamais seul au long cours (GINA). Secours > 2 fois/semaine : asthme insuffisamment contrôlé.
SAMA anticholinergique de courte durée	ipratropium (nébulisation) ; fénotérol + ipratropium (Bronchodual)	**Aigu grave, avec un BDCA**	**Exacerbation, avec un BDCA**	Nébulisations : prescription réservée aux pneumologues et pédiatres, sauf usage d'urgence (R5121-96 CSP).
BDLA bêta-2 de longue durée	formotérol, salmétérol, indacatérol, olodatérol ; vilantérol (en association)	**Fond, toujours avec un CSI**	**Fond (seul ou + LAMA)**	Le formotérol agit vite : il permet le schéma « fond + secours » avec un CSI (CSI-formotérol).
LAMA anticholinergique de longue durée	tiotropium, glycopyrronium, uméclidinium	**Asthme sévère avec exacerbation (en ajout)**	**Fond, 1re ligne**	Prudence : glaucome à angle fermé, adénome de prostate, rétention urinaire (RCP).
CSI corticoïde inhalé	béclométasone, budésonide, fluticasone, ciclésonide, mométasone (en association)	**Socle du fond**	**Seulement si exacerbations + éosinophiles ; jamais seul**	Rincer la bouche après la prise (candidose). BPCO : risque de pneumonie.

Asthme : GINA 2025 (international)

- **Piste 1, préférée** : **CSI-formotérol à faible dose** comme traitement de secours, seul aux paliers 1-2, puis en **« fond + secours »** aux paliers 3 à 5.
- **Piste 2** : CSI (± BDLA) en fond **+ BDCA** en secours, si le fond est bien pris.
- **BDCA seul non recommandé** : 3 flacons par an ou plus = risque accru d'exacerbation (12 ou plus : risque de décès).
- Palier 5 : ajout d'un LAMA, phénotypage, biothérapie (pneumologue).

Asthme : SPLF 2021 (France, adulte)

- **Palier 1** : BDCA à la demande ; budésonide-formotérol à la demande si non contrôlé.
- **Palier 2** : CSI à faible dose. **Palier 3** : CSI-BDLA (fond, ou fond + secours avec CSI-formotérol). BDLA seul : non recommandé.
- **Palier 4** : CSI dose moyenne à forte + BDLA. **Palier 5** : tiotropium, biothérapies (pneumologue).
- Contrôle optimal depuis 3 mois : **diminuer le CSI de 50 %** (sauf exacerbation dans l'année).

Ce que permettent les AMM françaises (RCP, 05/11/2026)

- **« Fond + secours »** avec le même inhalateur : AMM de **Symbicort** (dosages faibles, à partir de 12 ans) et d'**Innovair 100/6** (adulte). Symbicort : au-delà de 8 inhalations par jour, avis médical ; jusqu'à 12 par jour sur une courte période.
- **CSI-formotérol « à la demande seul »** (sans traitement de fond, piste 1 GINA paliers 1-2) : **non prévu par les RCP français** = hors AMM, à décider et tracer par le médecin.

BPCO : GOLD 2026 (stratégie) et HAS, parcours de soins BPCO

- **Pour tous** : arrêt du tabac, vaccinations, activité physique, réhabilitation respiratoire ; **BDCA (± SAMA) à la demande**.
- **Groupe A** (0-1 exacerbation modérée, peu de symptômes) : **un** bronchodilatateur de longue durée (LAMA ou BDLA).
- **Groupes B** (symptômes : mMRC ≥ 2 ou CAT ≥ 10) **et E** (≥ 2 exacerbations modérées ou ≥ 1 hospitalisation dans l'année) : **LAMA + BDLA**, un seul inhalateur de préférence.
- **Trithérapie** (CSI + LAMA + BDLA) : groupe E avec éosinophiles ≥ 300/mm³ d'emblée ; exacerbations sous LAMA + BDLA si éosinophiles ≥ 100/mm³. En dessous de 100 : CSI peu utile.
- **Pas d'association CSI + BDLA sans LAMA** dans la BPCO : quand un CSI est indiqué, préférer la trithérapie. **Jamais de CSI seul.**

Bien utiliser les inhalateurs en établissement

- **Vérifier la technique à chaque consultation** avant de changer de traitement (guide SPLF « Zéphyr »). Un seul type de dispositif si possible.
- **Poudre** (Turbuhaler, Diskus, Ellipta, Breezhaler…) : inspiration rapide et forte, parfois impossible (grand âge, troubles cognitifs, polyhandicap) → **aérosol doseur + chambre d'inhalation**, ou nébulisation sur prescription.
- Aide à la prise d'un inhalé : AS/AP (médicament non injectable) ; nébulisation : IDE, sur prescription ou protocole. Après un CSI : **rincer la bouche**.

Vision Moderne de la Santé
Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

ASTHME ET BPCO : LES TRAITEMENTS INHALÉS

Spécialités commercialisées et indications AMM

Molécule(s)	Spécialités commercialisées (dispositif)	Asthme	BPCO	Précisions
BÊTA-2 DE COURTE DURÉE (BDCA)				
Salbutamol 100 µg/dose	Ventoline (aérosol), Airomir Autohaler, Ventilastin Novolizer (poudre), Salbutamol Teva	**Secours, effort**	**Secours**	Enfant : chambre d'inhalation si besoin
Terbutaline 500 µg/dose	Bricanyl Turbuhaler (poudre)	**Secours, effort**	**Secours**	
Salbutamol 2,5 et 5 mg ; terbutaline 5 mg (nébulisation)	Ventoline unidoses ; Salbutamol Arrow, Teva, Viatris ; Terbutaline Arrow, Biogaran, Viatris	**Aigu grave**	**Exacerbation**	Prescription réservée (pneumologie, pédiatrie) sauf urgence
ANTICHOLINERGIQUES DE COURTE DURÉE (SAMA)				
Ipratropium 0,25 et 0,5 mg (nébulisation)	Atrovent Adultes 0,5 mg, Atrovent Enfants 0,25 mg ; Ipratropium Aguettant, Almus, Arrow, Cristers, EG, Sandoz, Teva, Viatris, Zentiva	**Aigu grave + BDCA**	**Exacerbation + BDCA**	Toujours avec un BDCA. Prescription réservée sauf urgence
Fénotérol + ipratropium 50/20 µg	Bronchodual (aérosol)	**Secours, effort**	**Fond si un seul bronchodilatateur ne suffit pas**	
BÊTA-2 DE LONGUE DURÉE (BDLA)				
Formotérol 12 µg	Foradil (Aerolizer), Formoair (aérosol), Asmelor Novolizer ; Formotérol Biogaran, EG, Viatris, Zentiva	**Fond, avec CSI**	**Fond**	Pas un traitement de la crise ; Foradil > 6 ans
Salmétérol 25 et 50 µg	Serevent (aérosol), Serevent Diskus	**Fond, avec CSI**	**Fond**	> 4 ans
Indacatérol 150-300 µg ; olodatérol 2,5 µg	Onbrez Breezhaler ; Striverdi Respimat	—	**Fond**	Adulte
ANTICHOLINERGIQUES DE LONGUE DURÉE (LAMA)				
Tiotropium 18 µg ; 2,5 µg/dose	Spiriva (HandiHaler), Tiotropium Biogaran Eolip, Viatris ; Spiriva Respimat	**Respimat : sévère avec exacerbation, en ajout**	**Fond**	Asthme : Spiriva Respimat seulement, dès 6 ans
Glycopyrronium 44 µg ; uméclidinium 55 µg	Seebri Breezhaler, Glycopyrronium Biogaran Axica ; Incruse Ellipta	—	**Fond**	Adulte
CORTICOÏDES INHALÉS (CSI)				
Béclométasone 50 à 250 µg/dose	Bécotide, Beclospray, Qvar Autohaler et spray, Ecobec, Bemedrex Easyhaler ; Béclométasone Teva	**Fond**	—	Qvar : dose plus faible (particules extrafines)
Budésonide 100 à 400 µg/dose	Pulmicort Turbuhaler, Novopulmon Novolizer	**Fond**	—	Enfant : selon RCP
Béclométasone 400-800 µg ; budésonide 0,5-1 mg (nébulisation)	Beclospin ; Budésonide Arrow, Biogaran, Cristers, EG, Evolugen, Sandoz, Teva, Viatris, Zentiva	**Fond si aérosol et poudre impossibles**	—	Enfant ; Beclospin : siffleur de 5 ans ou moins
Fluticasone (propionate) 50 à 500 µg	Flixotide (aérosol), Flixotide Diskus ; Propionate de fluticasone Teva	**Fond**	—	> 4 ans
Ciclésonide 80 et 160 µg/dose	Alvesco (aérosol)	**Fond**	—	À partir de 12 ans
CSI + BDLA				
Béclométasone + formotérol 100/6, 200/6	Innovair, Formodual (aérosol et Nexthaler) ; génériques Biogaran, EG, Teva, Viatris, Zentiva	**Fond ; 100/6 : fond + secours**	**100/6 : BPCO sévère avec exacerbations**	Adulte
Budésonide + formotérol 80 à 400/4,5 à 12	Symbicort Turbuhaler et Rapihaler, Duoresp Spiromax, Gibiter Easyhaler, Sandoz Forspiro	**Fond ; faibles dosages : fond + secours**	**VEMS < 70 % + exacerbations**	6-11 ans : 100/6 seulement ; fond + secours dès 12 ans
Fluticasone + salmétérol	Seretide, Seretide Diskus, Salfluair Easyhaler ; génériques Arrow, BGR, Biogaran, EG, Sandoz, Teva, Viatris, Zentiva	**Fond**	**Diskus 500/50 : VEMS < 60 % + exacerbations**	Dès 4 ans (faibles dosages)
Fluticasone + formotérol 50/5, 125/5	Flutiform (aérosol)	**Fond**	—	125/5 : à partir de 12 ans
Fluticasone (furoate) + vilantérol	Relvar Ellipta, Revinty Ellipta 92/22 et 184/22	**Fond, dès 12 ans**	**92/22 seulement**	1 inhalation par jour
Mométasone + indacatérol	Atectura Breezhaler	**Fond, dès 12 ans**	—	1 gélule par jour
BDLA + LAMA				
Uméclidinium + vilantérol ; indacatérol + glycopyrronium ; tiotropium + olodatérol	Anoro Ellipta, Laventair Ellipta (55/22) ; Ultibro Breezhaler (85/43) ; Spiolto Respimat (2,5/2,5)	—	**Fond**	Adulte
TRITHÉRAPIES CSI + BDLA + LAMA				
Fluticasone (furoate) + uméclidinium + vilantérol	Trelegy Ellipta, Elebrato Ellipta 92/55/22	—	**Modérée à sévère, après bithérapie**	Adulte ; 1 inhalation par jour
Béclométasone + formotérol + glycopyrronium	Trimbow 87/5/9 et 172/5/9 (aérosol), Trimbow 88/5/9 (Nexthaler)	**Adulte non contrôlé par CSI + BDLA, avec exacerbation**	**Modérée à sévère, après bithérapie**	Adulte ; 2 inhalations 2 fois par jour
Budésonide + glycopyrronium + formotérol	Trixeo Aerosphere 160/7,2/5	—	**Modérée à sévère, après bithérapie**	Adulte
Mométasone + indacatérol + glycopyrronium	Enerzair Breezhaler	**Adulte non contrôlé par CSI forte dose + BDLA, avec exacerbation**	—	Adulte

« Fond » = traitement continu ; « Secours » = à la demande. **Sources** : BDPM (ANSM) et EMA, commercialisation et RCP au 05/11/2026 ; GINA, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025 ; GOLD, Global Strategy for COPD, rapport 2026 ; Raherison-Semjen C et al., recommandations SPLF/SP2A asthme de l'adulte, actualisation 2021, Rev Mal Respir 2021;38:e1-e13 ; HAS, Guide du parcours de soins BPCO (actualisation 2019) ; art. R5121-96 CSP.

Vision Moderne de la Santé
Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.